

편두통 위장 증상에 가려진 진짜 원인

소화불량·메스꺼움으로 내원한 환자에서 놓치지 말아야 할 두통

성인 6명 중 1명

한국인 1년 유병률 17% — 여성은 남성의 2~3배, 30~40대 가장 흔합니다

17%

WHY IT MATTERS

편두통의 60~90%는 오심·구토 등 위장 증상을 동반합니다.
환자가 두통보다 소화불량을 먼저 호소하는 경우가 흔해, 내과에서
놓치기 쉬운 질환입니다. 정확히 진단하면 대부분 외래에서 잘
조절됩니다.

한국 성인 1년 편두통 유병률 — 일상에서 가장 흔히 마주치는
신경학적 질환입니다.

편두통이란

단순한 두통이 아니라, 뇌가 자극에 과민하게 반응하는 신경학적 질환

삼차신경혈관계 활성화와 피질 확산성 억제(CSD)가 만드는, 단순한 혈관성 두통이 아닌 뇌 자체의 과민반응입니다.

발작 사이에는 정상이지만, 한 번 발작이 시작되면 빛·소리·냄새·움직임 모든 자극이 증폭되어 느껴집니다. 위장 운동이 함께 멈추면서 오심·구토가 동반됩니다 — "체했다"고 표현하는 환자가 사실은 편두통 발작 중인 경우가 많습니다.



TYPICAL DURATION

4~72시간

치료하지 않거나 부분 치료된 한 번의 발작이 지속되는 시간.

DIAGNOSTIC THRESHOLD

5회 이상 발작

동일한 양상의 두통이 5회 이상 반복되면 편두통 진단을 고려합니다.

편두통은 종종 위장 질환처럼 옵니다

두통보다 소화 증상을 먼저 호소하는 환자가 흔합니다 — 4가지 표현 양상

PATTERN · 01

전구기 위장 증상 (Prodrome)

두통 시작 **24~48시간 전** 식욕 변화, 메스꺼움, 변비 또는 설사, 갈증 — 환자는 "체할 것 같다"고 표현합니다.

PATTERN · 02

위마비 (Migraine gastroparesis)

발작 중 위 배출이 **최대 78%**까지 지연됩니다. 식후 더부룩함·구토·경구약 흡수 저하 — 진통제가 듣지 않는 원인.

PATTERN · 03

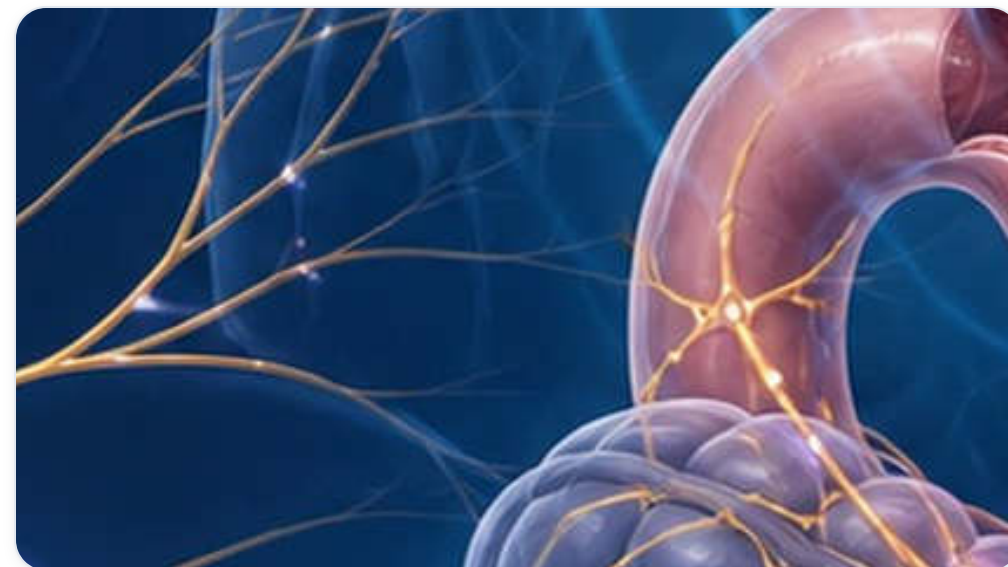
복부 편두통 (Abdominal migraine)

소아에 흔하나 성인도 가능. 반복적 중양 복통 + 오심·창백·식욕부진, 두통은 약하거나 없음. 내시경·복부검사 정상.

PATTERN · 04

순환성 구토 증후군 (CVS)

발작적 심한 오심·구토 (수 시간~수일) → 무증상기 → 다시 반복. 편두통 스펙트럼의 일부로 본인·가족력 편두통 흔함.



임상 포인트

소화기 정밀검사가 정상인데 반복되는 오심·구토가 있다면, "두통이 함께 오는지" 반드시 물어보세요. 환자는 별개로 생각해 먼저 말하지 않습니다.

이런 환자에서 편두통을 의심하세요

위장 증상을 주소로 내원했지만, 아래 6가지 단서가 있으면 편두통 가능성

CLUE · 01

발작적·간헐적 양상

증상이 며칠~몇 주 간격으로 반복되고 사이에 무증상기가 있습니다. 만성 위염과 다른 패턴입니다.

CLUE · 02

검사 모두 정상

위내시경·복부초음파·혈액검사 정상인데 증상이 지속·반복. PPI·제산제 효과 미미.

CLUE · 03

동반된 두통·머리 무거움

환자가 먼저 말하지 않더라도 "메스꺼울 때 머리도 같이 무겁지 않으세요?"라고 직접 물어보세요.

CLUE · 04

빛·소리·냄새 과민

증상이 있을 때 어두운 방을 찾거나, 평소보다 냄새·소음이 거슬리면 강력한 단서입니다.

CLUE · 05

가족력 — 편두통·멀미

부모·형제 편두통 또는 본인의 어린 시절 멀미·반복 복통 (소아 abdominal migraine) 병력.

CLUE · 06

생리·날씨와 연관

여성에서 생리 주기마다 또는 기상 변화·수면 부족 후 반복된다면 편두통 패턴과 일치합니다.

편두통의 4단계

각 단계마다 다른 증상 — 환자가 알아채면 조기 대응이 가능합니다



무엇이 발작을 일으키나

개인마다 다릅니다 — 두통일기로 본인의 트리거를 파악하는 것이 핵심

TRIGGER · 01

스트레스 · 스트레스 해소 직후

긴장이 풀린 주말·휴가 첫날 발작이 흔합니다 ("let-down headache").

TRIGGER · 02

수면 부족 또는 과다

평소보다 적게·많이 자도 유발. 규칙적인 수면 시간이 가장 중요합니다.

TRIGGER · 03

호르몬 변화 (여성)

생리 시작 2일 전~3일 후가 가장 흔한 발작 시점. 임신 중에는 호전, 폐경기 변동.

TRIGGER · 04

음식 · 음료

적포도주·맥주, 숙성치즈, 가공육(아질산), MSG, 인공감미료, 카페인 금단이 흔한 유발인자.

TRIGGER · 05

공복 · 탈수

끼니 거르기, 수분 부족도 트리거. 규칙적 식사가 예방의 기본.

TRIGGER · 06

환경 자극

강한 빛(눈부심), 큰 소리, 향수·세제 냄새, 기압 변화·날씨 — 사전 회피가 어려운 경우도 많습니다.

어떻게 진단하나요

영상검사는 위험 신호 배제용 — 진단은 병력과 ICHD-3 기준으로

ICHD-3 기준 — 두통 특성 2가지 + 동반증상 1가지가 5회 이상 반복되면 편두통입니다.

두통 특성 (2개 이상): ① 한쪽 ② 박동성 ③ 중등도~심한 강도 ④ 일상 활동에 의해 악화

동반 증상 (1개 이상): ① 오심·구토 ② 빛·소리 과민

지속 시간 4~72시간 (치료 안 했거나 부분 치료 시). 다른 질환으로 더 잘 설명되지 않음.

SCREENING TOOL

ID Migraine™

3문항: 빛 과민 / 일상 지장 / 오심 — 2개 이상 "예"면 편두통 가능성 93%.

IMAGING INDICATION

SNOOP10 양성 시

전형적 편두통은 영상 불필요. 위험신호(다음 슬라이드) 있을 때만 MRI/CT.

치료 — 급성기 · 예방

발작 시 빠른 진압 + 잦은 발작은 예방 치료 병행

ACUTE · 01

NSAIDs · 진통제

나프록센·이부프로펜 — 경증·중등도 발작의 1차. 발작 시작 즉시 **충분량** 복용이 핵심.

ACUTE · 02

트립탄 (Triptans)

수마트립탄·졸미트립탄·나라트립탄 — 중등도~중증 또는 NSAIDs 무반응 시. 오심 동반 시 비강·주사제 선택.

ACUTE · 03

제토제 (Antiemetics)

메토클로프라미드·돔페리돈 — 위마비로 인한 흡수 저하 해결. 진통제와 같이 처방하면 효과 상승.

PREVENT

예방 치료 적응증

월 4회 이상 또는 일상 지장 큰 발작 · 급성기약 효과 부족 · 약물 과용. 베타차단제·토피라메이트·CGRP 항체.

중요 진통제를 **월 10~15일 이상** 복용하면 약물과용두통(MOH)으로 두통이 만성화됩니다. "두통약을 자주 먹는다"는 환자는 반드시 빈도 확인.

이런 두통은 즉시 검사가 필요합니다

SNOOP10 — 이차성 두통(뇌출혈·종양·뇌수막염 등)을 시사하는 위험 신호

RED FLAG · 01

벼락 두통

Thunderclap — 수초 만에 극심한 두통으로 정점에 도달. 지주막하출혈 의심, 즉시 응급실.

RED FLAG · 02

50세 이후 첫 두통

늦은 나이에 처음 시작된 두통은 거대세포동맥염·종양·뇌졸중 평가가 필요합니다.

RED FLAG · 03

발열·경부강직 동반

Systemic symptoms — 뇌수막염·뇌염 의심. 의식 변화 동반 시 더욱 응급.

RED FLAG · 04

신경학적 결손

한쪽 마비·언어장애·시야 결손·의식 저하 — 일과성이라도 뇌졸중·TIA 평가.

RED FLAG · 05

점점 심해지는 양상

며칠~몇 주에 걸쳐 강도·빈도가 progressive하게 악화. 종양·만성 경막하혈종 감별.

RED FLAG · 06

자세·발살바로 악화

기침·재채기·배변 시 악화 또는 누우면 심해지는 두통 — 두개내압 변화 평가.

오늘부터 실천할 7가지

예방의 핵심은 규칙적 생활 + 본인의 트리거 파악

01 두통일기 작성 — 날짜·강도·
유발요인·복용약

02 매일 같은 시각에 자고 일어나기
(주말 포함)

03 끼니 거르지 않기 · 수분 **1.5~2L**
섭취

04 카페인 일정량 유지 (갑작스러운
증감·금단 회피)

05 발작 시작 즉시 처방받은 약 복용
(참다 먹으면 효과↓)

06 진통제 월 **10일 이하**로 제한
(약물과용두통 예방)

07 유산소운동 주 **3회 30분** · 명상·
요가

→ 두통일기를 다음 진료 때
가져오세요



정확한 진단, 편안한 일상

증상이 변하거나 새로운 양상이 생기면 언제든지 내원해 주세요.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요